

癌,占21.4%。而Woodruff等则提出卵巢库肯勃瘤的组织学为:生长在卵巢的肿瘤,镜下可见印戒状粘液细胞及卵巢间质内伴有肉瘤样浸润。临床诊断卵巢库肯勃瘤除CT表现外,还需结合临床材料才能做出正确诊断。CT检查还能清楚显示出肿瘤与周围组织的关系如膀胱、直肠侵犯及盆腔淋巴结转移,以及远处转移如腹水、肝及大网膜转移。同时CT对恶性肿瘤的分期有重要的意义,对临床治疗及手术方案的确定有重要的参考价值。由于CT有以上优点,且简便宜行,因此,CT检查是确诊卵巢恶性肿瘤的重要手段之一。

食品从业人员乙型肝炎表面抗原感染状况调查

(054000) 河北省邢台市卫生防疫站 李金珍

乙型肝炎是危害人民健康较为严重的传染病,乙型肝炎表面抗原(HBsAg)对乙型肝炎的发病与流行有着密切的关系,为了解和掌握HBsAg在食品从业人员中的感染状况,于1997年我们对3210名食品从业人员HBsAg进行了监测,现将结果报告如下:

1 调查对象和方法:对象为市区及城镇食品生产加工销售的从业人员3210名,其中男1940人,女1270人,按统一标准,填表登记、体检,询问病史和采用北京生物制品研究所乙型肝炎HBsAg血球,用反向血凝试验检测HBsAg,凡1:8以上出现凝集为阳性。

2 结果: 3210名食品从业人员中,HBsAg阳性者为157人,阳性率为4.9%,其中男106人,女50人,男女之间有显著差异(P<0.05),从阳性率分析,男性30岁组和40岁组为最高。

影响药物相互作用的几个问题

(054001) 河北省邢台市人民医院 王 华
(054000) 河北省邢台市卫生防站 李金珍

临床用药中,为了提高疗效或降低副作用,往往合用几种药物。但是应注意药物间的相互作用,现简述几种常用药物。

1 PH值的影响:胃蛋白酶、淀粉酶在碱性环境中药效降低,所以不易同碳酸氢钠、乳酸钠等碱性药物合用。而胰酶、红霉素在酸性环境中药效降低,因而不易与维生素C、氯化铵等酸性药物合用。

普鲁苯辛可松弛胃平滑肌,当合用红霉素左旋多巴时可在其酸性环境中停留时间过长,分解加快,药效降低。

2 血浆蛋白的影响:许多药物可与血浆蛋白形成可逆性结合,而暂时失去活性。但有些药物与血浆蛋白结合能力强,有些结合能力弱。结合能力强的可使结合能力弱的药物在血浆中的游离浓度提高,而使药效增强,甚至引起中毒。常见与血浆蛋白结合的药物有:水合氯醛、保泰松、磺胺药等。当这些药与口服降糖药D860合用时,应减少D860用量,否则可使D860药效增加而致低血糖。当合

参考文献

1.李果珍主编·临床CT诊断学·第一版·北京:中国科技出版社,1994;10:606
2.Joseph KT·Lee等著,周康荣、程家文译·腹部CT第一版·湖北科学技术出版社出版,1990;8:335
3.黄海平编译·螺旋CT在女性盆腔的临床应用·国外医学临床放射学分册1996;6:343
4.连利娟主编·林巧稚妇科肿瘤学·第二版·北京:人民卫生出版社,1994;640
5.吴剑波·转移性卵巢癌的CT诊断·中华放射学杂志1997;1:68

同时发现HBsAg阳性者的肝功能有正常和异常两种情况,HBsAg阳性的肝功能变化在男女之间没有差异(P>0.005)。

3 分析:这次调查HBsAg阳性率为4.9%低于有关报道,笔者认为这与加强食品行业的管理有关,特别是随着《食品卫生法》的实施,加大了食品卫生监督的力度,及时调离体检不合格人员使阳性率下降,HBsAg阳性者的血粪尿乳汁唾液及汗水均可感染健康人,由于职业的关系,食品从业人员一方面极容易接触乙肝感染者,另一方面也可将HBV传播给别人。为了减少乙型肝炎发病率,控制乙型肝炎传播,我们建议,每年从业人员健康体检时,可接种乙肝疫苗,如作为一项制定坚持下去,势必能进一步降低食品从业人员的HBsAg的感染率。

用抗凝血药华法令时,华法令作用增强,易致出血倾向,亦应调节华法令剂量。

3 药物代谢酶的影响:一些药物如异烟肼等可抑制机体药物代谢酶的活性,使药物的代谢过程延长,合用其它药物时而致其它药物药效增加。而苯巴比妥、水合氯醛、保泰松、安体舒通等可使药物的代谢过程加快,而合用其它药物时而致其它药物药效降低。

4 其它因素的影响。土霉素、强力霉素合用硫酸亚铁时,可形成络合物而使药效降低。而氨甲喋呤口服后的肠道正常菌群的代谢过程中减低毒性后才被吸收,当合用新霉素后,由于新霉素杀灭了正常菌群,而致氨甲喋呤的毒性增加。

利尿药用于心脏病人时可减轻水肿,但由于排钾作用可加强洋地黄的毒性。

认识到了药物相互作用的复杂性,临床用药不但要注意单一药物的不良反应,多种药物合用时更应综合考虑,慎之又慎。